D.QT 间期延长 低钾血症、尖端扭转型室速

13. 2023N45 A 男性，72 岁。高血压及心动过缓 25 年。3 个月来阵发心悸，当地医院诊断“心房颤动”，服用华法林治疗。1 周来出现多次黑矇，持续数秒可恢复。查体：P 42 次/分，BP 135/80mmHg，心界不大，心率 48 次/分，心律不齐，动态心电图可见频发 RR 间期大于 2.5s 的长间歇。在继续应用华法林的基础上，应选择的正确治疗是

慢　病态窦房结综合征(慢快综合征)　快
心输出量太低→缺血
窦房结病的很重→会出现长PP/长RR
心室率=300/RR大格=300/12.5=24　1个大格0.2s,一个小格0.04s
RR间期>2.5s,心室率<24

已做完了消融,最适合哪个起搏器?
DDD

A.服用胺碘酮转复心律

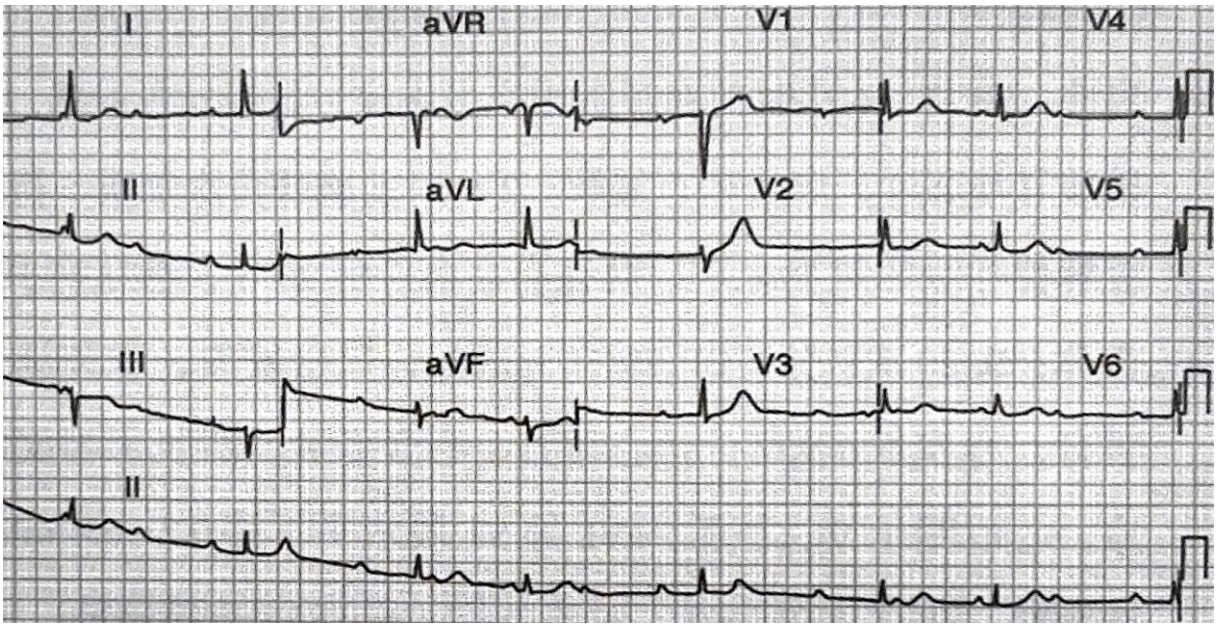
B.植入 DDD 型起搏器

C.射频消融加 β 受体拮抗剂

D.射频消融加起搏器 严重的缓慢型心律失常
房颤　VVI

14. 2024N48 A 女性，78 岁。1 年来明显乏力，活动时曾多次出现短暂黑矇。2 小时前突发头晕，随即出现短暂意识不清约 10 余秒钟。神志恢复后感胸闷、乏力，急送来院。查体：P 40 次/分，BP 110/60mmHg，平卧位，口唇无发绀，双肺(-)，心界不大，心率 42 次/分，心律不齐，第一心音强弱不等，各瓣膜听诊区未闻及杂音，腹部(-)。心电图如下。该患者最佳的治疗措施是

慢房颤



A.静脉给予地塞米松

B.静脉推注阿托品

C.置入临时心脏起搏器 使用永久起搏器:不可逆、持续时间长,反复发作

D.植入永久心脏起搏器

15. 2025N76-78 A 男性，55 岁。扩张型心肌病 15 年，慢性心力衰竭 3 年，长期服用呋塞米治疗。5 天前上感，发热，乏力。半小时前突发心悸，伴意识丧失半分钟，急来院诊治。查体：T 37.8℃，P 82 次/分，BP 90/60mmHg，神清，颈静脉充盈，双肺可闻及湿啰音，心界向左扩大，心率 98 次/分，心律不齐，心尖部第一心音低钝，肝肋下 1cm，肠鸣音弱，下肢无水肿，膝反射减弱，病理反射未引出。心电监测示频发多源性室性早搏。

导致低钾血症

76.该患者突发意识丧失最可能的病因是

A.全心衰竭

B.感染中毒性脑病

C.低血压